

TEMA 4.7 • DERMATOLOGÍA

Alopecias

PERFIL EUNACOM 6.01.1.008

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Trastornos Alopecicos

La alopecia refleja la pérdida folicular del volumen del cabello, debiendo discriminarse médicamente según un examen estructural del cuero cabelludo (buscando atrofia, indicios autoinmunes, o caída de quiebre folicular).

1. Alopecia Androgénica (Alopecia Común Estructural)

- **Fisiopatología:** Resultante genético-hereditaria con una sensibilidad celular desproporcionada local a terminales de **Andrógenos (Testosterona)**, generando atrofia, adelgazamiento y miniaturización lenta pero irreversible del pelo terminal. - **Cuadro Clínico Clásico Masculino:** Retroceso geográfico progresivo paulatino bitemporal y frontal (acentuando velozmente picos en clásica zona de "Las Entradas") más la pérdida circular en el vértice superior coronario. - **Factor Femenino:** Las mujeres pueden sufrirla también producto a picos o hiperandrogenismos locales, usualmente gatillados en menopausia terminal u ligados al **Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)**. - **Tratamiento Efectivo Médico:** 1. **Inhibidores Sistémicos de la 5-Alfa Reductasa:** Orales tomados de por vida, el pilar central **Finasteride** detiene el retroceso logrando engrosamiento remanente. (*Debe advertirse formalmente su grave reacción adversa colateral y limitante: Impotencia y Disfunción Sexual / Baja de libido sistémica*). 2. **Minoxidil Tópico Vasodilatador:** Reactivador local tópico coronario en espuma / spray estimulador sanguíneo. 3. **Terapias Femeninas Estrictas:** Los Anticonceptivos Orales puramente con componentes Anti-androgénicos en ciclo estable.

2. Alopecia Areata

- **Fisiopatología:** Falla **Auto-inmune** perjudicial y gatillada de brote. Muy referidamente desencadenada, exarcebada en pico tras episodios rotundos de crisis del estado anímico basal, **Estrés Psicosocial Ansioso reactivo prolongado**. - **Cuadro Clínico Diferencial Inspeccional:** Foco circunscrito redondo liso limpio del total de vellos baldíos. **Total ausencia de eritemas hiperémicos, purulentos e inflamatorios locales.** El pelo local NO "se quebra" cerca de la raíz dejándolo áspero; todo el hilo folicular cae íntegro y sin dolor de raíz de forma relámpago, permitiendo que el tacto en su interior luzca blando y blanco perfecto. (Se contrasta férreamente diferenciando a la purulenta y roja destructiva micótica Tiña Capitis en niños). - **Pronóstico Benigno Alto:** La inmensa mayoría de las Areata únicas redondas y limitadas (< 50% craneal) manifiestan repoblamiento folicular estético natural del cabello **Resolviéndose y recuperándose íntegro Solo por su cuenta.** Empeora a un pronóstico sombrío si cae la universalidad inmensa de los cabellos (Alopecia Universalis aguda > 50%), riesgo irrecuperable. - **Tratamiento Clínico:** - El primer pilar obligado: Absoluta e incesante **Educación sobre Control de Estrés** y apoyo del médico otorgando paciencia extrema temporal y optimismo en la espera clínica resolutive (Meses). - Casos Resistentes Estéticos o ansiosos persistentes: **Corticoides Infiltrados por Inyecciones Intralesionales** bajo el cuero cabelludo en consultorio, o

subsidiariamente Cremas de Corticoides de Ultra-Potencia friccionadas en la placa (Ej: *Clobetasol*). - Casos catastróficos resistentes extensos (>50%): Derivan a Dermatólogo para prescripción del control molecular inmune Oral con Fármacos inhibidores *JAK biológicos (Baricitinib)*. - **No procede ni sirve NUNCA Trasplante Quirúrgico Reinjerto Capilar:** Puesto que asoma al problema que la base corporal autoinmune lo percibe erróneo celular de igual forma, tumbando el folículo insertado por el cirujano estético al corto ciclo y fracasando en vano la inserción.

3. Alopecia Cicatricial Definitiva Crónica

- **Fisiopatología Estructural:** La raíz es borrada de mapa cutáneo; existe necrosis o injuria que destruye completamente y suplanta todos los bulbos capilares profundos dérmicos mediante tejido fibroblástico endurecido inerte post-trauma o patología inflamatoria esclerosante penetrante profunda subdérmica agresiva preexistente focalizada (Ej: Por quemaduras extensas térmicas directas, Lupus Cutáneo Discoide Crónico activo mal cuidado crónico). - **Cuadro y Manejo Quirúrgico:** Es total e absolutamente crónico basal ausente **Permanente Irreversible sin recuperación fisiológica con tratamiento de pastilla.** El abordaje de sustitución estética o reconstructivo consiste en aplicar Peluca natural armada o derechamente el someter a cirugías de **Implante Cirúrgico de Foliculos de Cabello (Trasplante)** cruzados bajo injertos funcionales artificiales (pues el tejido crónico actual muerto fibroso base ha curado y ya no manifiesta ataques reaccionarios).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Qué hallazgo clínico es patognomónico de la alopecia areata?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Alopecias. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La alopecia androgénica es la más frecuente y requiere andrógenos más predisposición genética.
- En hombres la alopecia androgénica produce calvicie en patrón masculino con retroceso bitemporal y vértex.
- La alopecia areata es autoinmune con pérdida delimitada sin inflamación y el pelo periférico no quebrado.
- El pelo en signo de exclamación es el hallazgo patognomónico de la alopecia areata.
- La alopecia areata mayor al cincuenta por ciento del cuero cabelludo tiene mal pronóstico de recuperación.
- Los inhibidores de JAK como baricitinib y ritlecitinib son nuevos tratamientos para alopecia areata severa.
- Las alopecias cicatriciales producen pérdida permanente e irreversible del folículo piloso.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ALOPECIAS)

PREGUNTA 1

¿Qué hallazgo clínico es patognomónico de la alopecia areata?

- A) Las placas eritematodescamativas en el borde del cuero cabelludo
- B) El pelo en signo de exclamación en la periferia de la placa alopécica
- C) Los pits ungueales asociados a la pérdida de cabello difusa
- D) La cicatriz brillante en el centro de la placa alopécica
- E) El prurito intenso en la zona de pérdida con descamación visible

PREGUNTA 2

¿Cuál es la alopecia más frecuente en la población general?

- A) La alopecia areata autoinmune con pérdida en parches circulares
- B) La alopecia cicatricial post-lupus eritematoso sistémico
- C) La alopecia androgénica genética que requiere presencia de andrógenos
- D) La alopecia difusa por déficit de hierro o hipotiroidismo
- E) La alopecia por tracción crónica de estilos de peinado ajustados

PREGUNTA 3

¿Qué indica que una alopecia areata tiene mal pronóstico de recuperación?

- A) La afectación de la barba y cejas además del cuero cabelludo
- B) La presencia de múltiples placas pequeñas en vez de una sola grande
- C) La afectación mayor al cincuenta por ciento del cuero cabelludo
- D) La presencia de pits ungueales asociados a la pérdida del cabello
- E) El inicio en la infancia antes de los doce años de edad

RESUMEN: ALOPECIAS

Las alopecias se clasifican en no cicatriciales, que permiten la recuperación del cabello, y cicatriciales, donde la pérdida es permanente. La alopecia androgénica es la más frecuente de todas, tiene base genética y requiere la presencia de andrógenos. En hombres produce la calvicie en patrón masculino con retroceso bitemporal y vértex, mientras que en mujeres produce un adelgazamiento difuso con conservación de la línea frontal. El tratamiento es con finasteride oral en hombres y minoxidil tópico en ambos sexos. La alopecia areata es autoinmune y se caracteriza por pérdida de cabello en un área bien delimitada, circular u ovalada, sin inflamación ni descamación visible, y con el pelo periférico no quebrado que se puede trazar hasta la piel. El signo del pelo en signo de exclamación es patognomónico. La afectación mayor al cincuenta por ciento del cuero cabelludo tiene mal pronóstico. El tratamiento son los corticoides intralesionales y en casos refractarios los inhibidores de JAK como baricitinib y ritlecitinib. Las alopecias cicatriciales por trauma, quemaduras o lupus producen pérdida permanente y el tratamiento definitivo es el trasplante capilar.